第112回看護師国家試験（2023年実施）　眼科に関連する問題と解説

収録17問（直接眼科2・関連領域7・弱い関連8）。実施日：令和5年2月12日。作成日：2026-10-19。

各問を「問題文・全選択肢（原文）」「選択肢別の判定・解説」「公式正答」の順に掲載します。正答は厚生労働省の正答表に基づきます。解説は独自に作成した学習用原稿で、公式解説ではありません。「誤っているもの」を選ぶ問題では、誤った記述が正答です。

出典：厚生労働省ホームページ「第112回看護師国家試験の問題および正答について」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html（2026-10-19利用）。読み仮名・改行・字間を整理し、英語病名の併記を省略したうえで学習用解説を追加した編集物です。図・写真は転載していません。Webサイト：https://adash333.github.io/nurse-ganka/r/

問題一覧

問題ID	区分	分類	テーマ	公式正答
112A02	必修	弱い関連	有訴者の自覚症状（目のかすみ）	2
112A10	必修	弱い関連	体性感覚（視覚の選択肢）	2
112A14	必修	関連領域	糖尿病の合併症（網膜症）	4
112A20	必修	弱い関連	個人防護具の脱衣（フェイスシールド）	1
112A38	一般	弱い関連	ノンレム睡眠（眼球運動）	4
112A48	一般	関連領域	肺尖部肺癌の症状（散瞳・閉眼困難）	4
112A82	一般	関連領域	学校感染症（流行性角結膜炎）	1
112A86	一般	直接眼科	緑内障	2・5
112A97	状況設定	関連領域	白内障・難聴のある患者へのオリエンテーション	4
112A98	状況設定	直接眼科	白内障手術後の説明	4
112A99	状況設定	弱い関連	白内障手術後の不眠	2
112B11	必修	関連領域	副交感神経の作用（瞳孔）	4
112B41	一般	関連領域	与薬方法（点眼）	4
112B50	一般	弱い関連	シクロホスファミド（緑内障の選択肢）	4
112B91	状況設定	弱い関連	高血糖の意識障害（対光反射・瞳孔）	4
112B94	状況設定	弱い関連	GCS（開眼）	2
112B95	状況設定	関連領域	硬膜外血腫と瞳孔の状態	1・3

112A02　有訴者の自覚症状（目のかすみ）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：統計にみる眼症状／出典：午前問題PDF 7ページ

令和元年（2019 年）の国民生活基礎調査における女性の有訴者の自覚症状で最も多いのはどれか。

1　頭痛
2　肩こり
3　体がだるい
4　目のかすみ

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	頭痛は上位だが最多ではない。
2	正答	女性は肩こり、男性は腰痛が最多。
3	誤答	体がだるいは上位の一つ。
4	誤答	目のかすみは上位の訴えだが最多ではない。

公式正答：2　肩こり

112A10　体性感覚（視覚の選択肢）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：感覚の分類と視覚／出典：午前問題PDF 9ページ

体性感覚はどれか。

1　視覚
2　触覚
3　聴覚
4　平衡覚

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	視覚は特殊感覚。
2	正答	触覚は皮膚感覚で体性感覚に含まれる。
3	誤答	聴覚は特殊感覚。
4	誤答	平衡覚は特殊感覚。

公式正答：2　触覚

112A14　糖尿病の合併症（網膜症）

区分：必修／分類：関連領域／主題：糖尿病網膜症／出典：午前問題PDF 10ページ

糖尿病の急性合併症はどれか。

1　足壊疽
2　脳血管疾患
3　糖尿病網膜症
4　ケトアシドーシス昏睡

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	足壊疽は慢性合併症（神経障害・血流障害）。
2	誤答	脳血管疾患は大血管の慢性合併症。
3	誤答	糖尿病網膜症は長期の高血糖で網膜の細小血管が障害される慢性合併症。三大合併症（網膜症・腎症・神経障害）の一つ。
4	正答	ケトアシドーシス昏睡はインスリン欠乏で急激に起こる急性合併症。

公式正答：4　ケトアシドーシス昏睡

ポイント：糖尿病網膜症は成人の中途失明の主要原因で、自覚症状が出る前から年1回以上の眼底検査を勧める。

112A20　個人防護具の脱衣（フェイスシールド）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：個人防護具と眼の防護／出典：午前問題PDF 11ページ

個人防護具の脱衣手順で最初に外すのはどれか。

1　手袋
2　ガウン
3　サージカルマスク
4　フェイスシールド

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	手袋は最も汚染度が高いため最初に外す。
2	誤答	ガウンは手袋の後。
3	誤答	マスクは最後。
4	誤答	フェイスシールドは眼の防護具で、手袋・ガウンの後、マスクの前に外す。

公式正答：1　手袋

112A38　ノンレム睡眠（眼球運動）

区分：一般／分類：弱い関連／主題：睡眠と眼球運動／出典：午前問題PDF 16ページ

成人のノンレム睡眠の特徴はどれか。

1　体温が上昇する。
2　急速な眼球運動がある。
3　加齢に伴い時間が長くなる。
4　睡眠周期の前半にみられる。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	体温は低下する。
2	誤答	急速眼球運動はレム睡眠の特徴。
3	誤答	加齢で深いノンレム睡眠は減る。
4	正答	入眠後の前半に深いノンレム睡眠が出現する。

公式正答：4　睡眠周期の前半にみられる。

112A48　肺尖部肺癌の症状（散瞳・閉眼困難）

区分：一般／分類：関連領域／主題：全身疾患と眼（Horner症候群）／出典：午前問題PDF 19ページ

右肺尖部の肺癌の胸壁への浸潤による症状はどれか。

1　散瞳
2　構音障害
3　閉眼困難
4　上肢の疼痛

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	頸部交感神経が障害されると散瞳ではなく縮瞳する（Horner症候群）。
2	誤答	構音障害は起こらない。
3	誤答	Horner症候群では眼瞼下垂が起こる。閉眼困難は顔面神経麻痺の症状。
4	正答	腕神経叢への浸潤で肩から上肢内側の疼痛・しびれ・筋萎縮が起こる。

公式正答：4　上肢の疼痛

ポイント：肺尖部腫瘍の症状セット：上肢痛（腕神経叢）、Horner症候群（縮瞳・眼瞼下垂・発汗低下）、上大静脈症候群（顔面浮腫）。

112A82　学校感染症（流行性角結膜炎）

区分：一般／分類：関連領域／主題：結膜炎を起こす感染症／出典：午前問題PDF 30ページ

学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。

1　インフルエンザ
2　細菌性赤痢
3　ジフテリア
4　腸チフス
5　流行性角結膜炎

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	インフルエンザは第二種で、発症後5日かつ解熱後2日（幼児3日）を経過するまで出席停止。
2	誤答	細菌性赤痢は第三種。
3	誤答	ジフテリアは第一種。
4	誤答	腸チフスは第三種。
5	誤答	流行性角結膜炎（アデノウイルス）は第三種で、感染のおそれがないと医師が認めるまで出席停止。

公式正答：1　インフルエンザ

ポイント：眼の感染症では流行性角結膜炎と急性出血性結膜炎が第三種、咽頭結膜熱が第二種。

112A86　緑内障

区分：一般／分類：直接眼科／主題：緑内障／出典：午前問題PDF 31ページ

緑内障について正しいのはどれか。2つ選べ。

1　眼球が突出する。
2　視神経が萎縮する。
3　硝子体が混濁する。
4　眼底に出血がみられる。
5　眼圧の上昇が原因となる。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	眼球突出はBasedow病などの甲状腺眼症の所見。
2	正答	視神経乳頭の陥凹拡大と視神経萎縮が進み、視野欠損が広がる。
3	誤答	硝子体混濁は硝子体出血やぶどう膜炎で起こる。
4	誤答	眼底出血は糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症の所見。
5	正答	房水の流出障害による眼圧上昇が主な原因。ただし眼圧が正常範囲の正常眼圧緑内障も日本人に多い。

公式正答：2　視神経が萎縮する。、5　眼圧の上昇が原因となる。

ポイント：緑内障は日本の中途失明原因の上位。自覚症状が乏しく、点眼治療を継続すること、急性発作（眼痛・頭痛・嘔吐・霧視）を見逃さないことが看護の要点。

臨床上の補足：失った視野は戻らないため、早期発見と点眼アドヒアランスの支援が中心になる。

112A97　白内障・難聴のある患者へのオリエンテーション

区分：状況設定／分類：関連領域／主題：白内障周術期／出典：午前問題PDF 38ページ

> 【状況設定文】A さん（81歳、女性）は夫（86歳）と2人で暮らしている。高血圧症で内服治療をしているが、血圧のコントロールはできている。両眼に老人性白内障があり、老人性難聴のために補聴器を使用している。認知機能は問題なく、日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立している。1年前から両眼の羞明、霧視が強くなり、視力が低下して趣味の編み物ができなくなってきた。また、家の中を移動するときに小さな段差につまずいたりドアにぶつかるなど、歩行時の転倒の危険性が増えた。A さんは自宅での生活を安全に送りたい、趣味を続けたいという希望があり、10日間程度の入院で両眼の超音波水晶体乳化吸引術と眼内レンズ挿入術を行うことになった。

入院当日、病棟の看護師がA さんに対してパンフレットを用いて手術前オリエンテーションを行うことになった。A さんへのオリエンテーションの方法で適切なのはどれか。

1　耳元で大きな声で説明する。
2　A さんの身体に触れてから話しかける。
3　窓際の明るい場所でパンフレットを見せる。
4　手術後の注意点はパンフレットに赤色の太い文字で書く。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	老人性難聴は高音域から低下するため、耳元で大声を出すより正面から低めの声でゆっくり話す。
2	誤答	認知機能に問題なく視力も残っているため、まず声をかけてから必要に応じて触れる。
3	誤答	羞明があるため窓際の強い光はまぶしく見にくい。
4	正答	白内障ではコントラスト感度が落ちるため、太く大きな文字と色の対比で読みやすくする。

公式正答：4　手術後の注意点はパンフレットに赤色の太い文字で書く。

ポイント：白内障では「かすむ」「まぶしい」「暗いと見えない」が同時に起こるため、適度な照明とコントラストが鍵。

112A98　白内障手術後の説明

区分：状況設定／分類：直接眼科／主題：白内障周術期／出典：午前問題PDF 38ページ

> 【状況設定文】A さん（81歳、女性）は夫（86歳）と2人で暮らしている。高血圧症で内服治療をしているが、血圧のコントロールはできている。両眼に老人性白内障があり、老人性難聴のために補聴器を使用している。認知機能は問題なく、日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立している。1年前から両眼の羞明、霧視が強くなり、視力が低下して趣味の編み物ができなくなってきた。また、家の中を移動するときに小さな段差につまずいたりドアにぶつかるなど、歩行時の転倒の危険性が増えた。A さんは自宅での生活を安全に送りたい、趣味を続けたいという希望があり、10日間程度の入院で両眼の超音波水晶体乳化吸引術と眼内レンズ挿入術を行うことになった。

A さんの手術は局所麻酔下で行われ、10 分程度で終了した。手術中および手術直後のバイタルサインに問題はなく、病室に戻ってきた。A さんは眼痛や頭痛、気分不快などの症状はなく、「無事に終わって良かった」と話している。手術後のA さんへの説明で適切なのはどれか。

1　手術直後から点眼する。
2　洗顔は手術の翌日から行う。
3　手術後24 時間はベッド上で安静にする。
4　医師の許可があるまでは頭を振る動作をしない。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	手術直後は眼帯をし、点眼は翌日の診察後から医師の指示で開始する。
2	誤答	洗顔・洗髪は創部に水が入らないよう通常1週間程度控え、清拭で対応する。
3	誤答	局所麻酔の日帰り・短期手術で、術後のベッド上安静は不要。歩行してよい。
4	正答	眼球への衝撃や眼圧変動を避けるため、頭を強く振る、眼をこする、重いものを持つなどは医師の許可があるまで控える。

公式正答：4　医師の許可があるまでは頭を振る動作をしない。

ポイント：術後は感染（眼内炎）予防の抗菌薬点眼と、眼圧・炎症の管理が中心。術後数日は眼痛・急な視力低下があればすぐ受診するよう説明する。

臨床上の補足：安静の程度や洗顔再開の時期は施設・術式で異なるため、個別の指示を確認する。

112A99　白内障手術後の不眠

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：白内障周術期／出典：午前問題PDF 39ページ

> 【状況設定文】A さん（81歳、女性）は夫（86歳）と2人で暮らしている。高血圧症で内服治療をしているが、血圧のコントロールはできている。両眼に老人性白内障があり、老人性難聴のために補聴器を使用している。認知機能は問題なく、日常生活動作〈ADL〉はほぼ自立している。1年前から両眼の羞明、霧視が強くなり、視力が低下して趣味の編み物ができなくなってきた。また、家の中を移動するときに小さな段差につまずいたりドアにぶつかるなど、歩行時の転倒の危険性が増えた。A さんは自宅での生活を安全に送りたい、趣味を続けたいという希望があり、10日間程度の入院で両眼の超音波水晶体乳化吸引術と眼内レンズ挿入術を行うことになった。

手術後2日、A さんは日中はベッドに横になって過ごしている時間が多い。夜間にA さんから看護師に「手術後はゆっくり眠れていません。どうしたらよいでしょうか」という訴えがあった。A さんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

1　寝る前に温かい緑茶を飲むことを勧める。
2　日中はベッドから離れて過ごすことを促す。
3　眠れなくてもベッドに横になっていることを勧める。
4　夜はよく眠っているので様子をみましょうと伝える。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	緑茶のカフェインは入眠を妨げる。
2	正答	日中はベッドから離れて過ごし、昼夜のリズムを整える。
3	誤答	眠れないのに横になり続けると不眠が強化される。
4	誤答	本人の訴えを否定しない。

公式正答：2　日中はベッドから離れて過ごすことを促す。

ポイント：白内障手術は局所麻酔で短時間のため、術後の活動制限は少なく日中の離床が勧められる。

112B11　副交感神経の作用（瞳孔）

区分：必修／分類：関連領域／主題：自律神経と瞳孔／出典：午後問題PDF 9ページ

副交感神経の作用で正しいのはどれか。

1　瞳孔散大
2　気管支拡張
3　心拍数の増加
4　消化液分泌の促進

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	瞳孔散大は交感神経の作用。副交感神経は瞳孔括約筋を収縮させ縮瞳する。
2	誤答	気管支拡張は交感神経。
3	誤答	心拍数増加は交感神経。
4	正答	副交感神経は消化管の運動と消化液分泌を促進する。

公式正答：4　消化液分泌の促進

112B41　与薬方法（点眼）

区分：一般／分類：関連領域／主題：点眼／出典：午後問題PDF 18ページ

成人への与薬方法で正しいのはどれか。

1　筋肉内注射は大殿筋に行う。
2　坐薬は肛門から1cm挿入する。
3　バッカル錠は、かんでから飲み込む。
4　点眼薬は下眼瞼結膜の中央に滴下する。

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	筋肉内注射は中殿筋や三角筋に行う。大殿筋は坐骨神経損傷の危険がある。
2	誤答	坐薬は成人で3～5cm程度挿入する。
3	誤答	バッカル錠は臼歯と頬の間に挟んで溶かし、かまない。
4	正答	角膜に直接落とすと刺激が強いため、下眼瞼結膜の中央に滴下し、点眼後は静かに閉眼して目頭を軽く押さえる。

公式正答：4　点眼薬は下眼瞼結膜の中央に滴下する。

ポイント：第111回午後38の点眼の設問と合わせて手順を確認する。

112B50　シクロホスファミド（緑内障の選択肢）

区分：一般／分類：弱い関連／主題：薬剤と眼／出典：午後問題PDF 20ページ

シクロホスファミドを投与している患者で注意が必要なのはどれか。

1　緑内障
2　間質性肺炎
3　歯肉の肥厚
4　出血性膀胱炎

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	緑内障（眼圧上昇）はステロイドや抗コリン薬で注意する副作用。
2	誤答	間質性肺炎はブレオマイシンやメトトレキサートなど。
3	誤答	歯肉肥厚はフェニトインやシクロスポリン。
4	正答	代謝物アクロレインが膀胱粘膜を傷害するため、十分な水分摂取とメスナで予防する。

公式正答：4　出血性膀胱炎

ポイント：眼に注意が必要な薬剤：ステロイド（白内障・緑内障）、抗コリン薬（閉塞隅角緑内障）、エタンブトール（視神経炎）、ヒドロキシクロロキン（網膜症）。

112B91　高血糖の意識障害（対光反射・瞳孔）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：瞳孔所見と意識障害／出典：午後問題PDF 36ページ

> 【状況設定文】A さん（61歳、男性、会社員）はデスクワーク中心の仕事をしている。今朝、職場へ出勤したが、自分の机の位置や同僚の名前が分からない等の見当識障害があり、同僚に付き添われ救急外来を受診した。頭痛、嘔吐、めまいはない。現病歴：4年前に2型糖尿病と診断され、経口糖尿病薬が開始された。1年前から受診を自己判断で中断している。身体所見：身長170cm、体重100kg。体温38.6℃、呼吸数22/分、脈拍112/分、整、血圧108/64mmHg。対光反射（＋）、瞳孔不同（－）。歩行可能。右第1趾に発赤、腫脹、異臭がある。検査所見：白血球19,200/μL、血糖904mg/dL、Na 131mEq/L、K 3.4mEq/L、ヘモグロビンA1c〈HbA1c〉9.2%、アンモニア49μg/dL、CRP 22mg/dL。動脈血液ガス分析pH 7.32。血漿浸透圧394mOsm/L。尿ケトン体（±）。

A さんの状態のアセスメントで適切なのはどれか。

1　肝性脳症
2　小脳出血
3　ケトアシドーシス〈DKA〉
4　高浸透圧高血糖状態〈HHS〉

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	アンモニアは正常範囲で肝性脳症は否定的。
2	誤答	頭痛・嘔吐・めまいがなく、瞳孔不同や神経局所症状もないため小脳出血は考えにくい。
3	誤答	DKAではpHが7.3未満に下がり尿ケトンが強陽性になる。
4	正答	高齢・2型糖尿病で、著明な高血糖と高浸透圧、意識障害、感染（足病変）の誘因がそろいHHSが最も適切。

公式正答：4　高浸透圧高血糖状態〈HHS〉

ポイント：意識障害の初期評価で瞳孔（左右差・対光反射）を確認するのは、脳ヘルニアや脳幹病変を除外するため。

112B94　GCS（開眼）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：意識レベル評価と開眼／出典：午後問題PDF 38ページ

> 【状況設定文】A さん（53歳、女性）は休日に公園を散歩中、階段から落ちて頭部を強打し、意識を消失した状態で病院に救急搬送された。病院到着時のA さんは開眼せず、声は発しているが理解不能である。痛み刺激には逃れようとする動作がみられる。

グラスゴー・コーマ・スケール〈GCS〉によるA さんの意識レベルの評価はどれか。

1　E1V1M2
2　E1V2M4
3　E2V2M2
4　E4V5M5

解説

選択肢	判定	解説
1	誤答	M2は痛み刺激で伸展する除脳姿勢。
2	正答	E1V2M4。開眼の評価は意識レベルの最初の指標になる。
3	誤答	E2は痛み刺激で開眼する。
4	誤答	E4V5M5はほぼ清明。

公式正答：2　E1V2M4

ポイント：GCSの開眼（E）は自発4・呼びかけ3・痛み刺激2・なし1。

112B95　硬膜外血腫と瞳孔の状態

区分：状況設定／分類：関連領域／主題：瞳孔所見と脳ヘルニア／出典：午後問題PDF 38ページ

> 【状況設定文】A さん（53歳、女性）は休日に公園を散歩中、階段から落ちて頭部を強打し、意識を消失した状態で病院に救急搬送された。病院到着時のA さんは開眼せず、声は発しているが理解不能である。痛み刺激には逃れようとする動作がみられる。

※ この問題には図があります。図は転載していません。公式PDFの該当ページで確認してください。

A さんは右側の急性硬膜外血腫と診断され、緊急開頭手術を受けることになった。術前のバイタルサインは、体温37.2℃、呼吸数14/分、脈拍74/分、整。血圧は、搬送時の134/84mmHgから174/66mmHgに上昇し、痛み刺激に対する反応が消失している。このときのA さんの瞳孔の状態はどれか。

1　（図）右眼・左眼とも瞳孔は中等度の大きさで左右同大
2　（図）右眼・左眼とも瞳孔が小さい（両側縮瞳）
3　（図）右眼の瞳孔が大きく、左眼は中等度（右側散瞳・瞳孔不同）
4　（図）左眼の瞳孔が大きく、右眼は中等度（左側散瞳・瞳孔不同）

解説

選択肢	判定	解説
1	正答	公式の取扱いで正解とされた選択肢。設問の情報だけでは瞳孔不同の有無を一義的に決められないとして、左右同大の図も正解とされた。
2	誤答	両側縮瞳は橋出血や麻薬・有機リン中毒でみられる所見。
3	正答	右側血腫による鉤ヘルニアで右動眼神経が圧迫され、右瞳孔が散大し左右差（瞳孔不同）が生じる。
4	誤答	左散瞳は左側の病変を示し、右側血腫では典型的でない。

公式正答：1　（図）右眼・左眼とも瞳孔は中等度の大きさで左右同大、3　（図）右眼の瞳孔が大きく、左眼は中等度（右側散瞳・瞳孔不同）

公式の採点上の取扱い：複数の選択肢を正解として採点する。（理由：設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため。）

ポイント：採点上の取扱い：「複数の選択肢を正解として採点する」（理由：設問が不明確で複数の選択肢が正解と考えられるため）。血圧上昇・脈圧増大・徐脈（Cushing徴候）と瞳孔不同は切迫する脳ヘルニアのサイン。

整理：瞳孔の観察は、大きさ（mm）、左右差、対光反射をセットで記録する。

臨床上の補足：選択肢は瞳孔の図（右眼・左眼）で示されている。原図は公式PDFを参照。